

Współwystępujące *zaburzenia w PPU*

Rzadko PPU występuje samo. 60–80% pacjentów ma drugą diagnozę — depresję, lęk, ADHD, traumę. Bez jej leczenia terapia PPU często zawodzi.

CZAS: 25 min Psychoedukacja diagnostyczna

ŹRÓDŁO: Ballester-Arnal i wsp. (2017); Wéry & Billieux (2017); Kraus (2018)

JAK UŻYWAĆ

Karta porządkuje wiedzę o **współwystępowaniu** (ang. *comorbidity*) PPU z innymi zaburzeniami psychicznymi. Przedstawia: 1) **częstość** głównych współwystępujących zaburzeń, 2) **kierunki wpływu** — jak jedno zaburzenie napędza drugie, 3) zasady *zintegrowanego leczenia*, 4) jak rozpoznać u siebie. Karta jest *diagnostycznym kompasem* — pomaga zrozumieć, że PPU rzadko jest „głównym problemem”, częściej jest częścią szerszego obrazu.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Ballester-Arnal i wsp. (2017, n=2 543, badanie hiszpańskie) i Wéry & Billieux (2017, przegląd 28 badań) wykazali, że **60-80% osób z PPU klinicznym** ma co najmniej jedno współwystępujące zaburzenie. Najczęstsze: depresja (40–50%), zaburzenia lękowe (30–40%), ADHD (20–30%), trauma / PTSD (15–25%), zaburzenia osobowości (30–40%). Wniosek: **terapia PPU bez adresowania współwystępujących zaburzeń** daje skuteczność na poziomie 30–40%. Z *zintegrowanym leczeniem* obu — 60–70% (Hallberg i wsp. 2019). Stąd diagnostyka różnicowa powinna zawsze obejmować screening głównych zaburzeń współwystępujących.

01 = Pięć najczęstszych współwystępowań

ZABURZENIE	CZĘSTOŚĆ	MECHANIZM RELACJI	IMPLIKACJE TERAPEUTYCZNE
<i>Depresja</i>	40–50%	PPU jako sposób ucieczki od dysforii; po użyciu — wzmocnienie wstydu i depresji	SSRI + CBT depresji + CBT-PPU jednocześnie
<i>Zab. lękowe</i>	30–40%	PPU jako szybkie znieczulenie lęku; cykl: lęk → porno → ulga → wstyd → lęk	CBT-lęk + alternatywne strategie regulacji
<i>ADHD</i>	20–30%	Niedobór dopaminy → szukanie szybkiej stymulacji; impulsywność osłabia kontrolę	Leczenie ADHD (atomoksetyna, ostrożnie stymulanty) + środowiskowe modyfikacje
<i>Trauma / PTSD</i>	15–25%	PPU jako znieczulenie objawów; niekiedy jako re-enactment traumy	Etapowa terapia: stabilizacja → terapia traumy (EMDR / PE) → integracja
<i>Zab. osobowości</i>	30–40%	PPU jako wzorzec regulacji emocji (BPD), kompensacji (NPD), impulsywności (ASPD)	Długoterminowa terapia (ST, DBT, MBT)

02 ☉ Trzy zasady leczenia podwójnej diagnozy w PPU

1 · JEDNOCZEŚNIE, NIE SEKWENCYJNIE

Nie „*najpierw zatrzymaj porno, potem leczyć depresję*” — bo bez leczenia depresji nie zatrzymasz porno. Oba zaburzenia równolegle.

2 · JEDEN ZESPÓŁ

Idealnie ten sam terapeuta lub blisko współpracujący zespół (psycholog + psychiatra). Pacjent nie powinien „krążyć” między specjalistami niesynchronizowanymi.

3 · HIERARCHIA KLINICZNA

Niektóre zaburzenia mają *priorytet*: aktywna psychoza, ciężkie myśli samobójcze, ciężka mania — najpierw stabilizacja, potem praca z PPU.

03 ✎ Twoja autoanaliza — screening

DEPRESJA

— smutek, anhedonia, beznadzieja, myśli samobójcze (TAK / NIE / czasem)

LĘK

— ataki paniki, fobia społeczna, lęk uogólniony

ADHD

— trudności z koncentracją, impulsywność, prokrastynacja od dziecka

TRAUMA / PTSD

— flashbacki, koszmary, unikanie miejsc/sytuacji

ZABURZENIE OSOBOWOŚCI

— niestabilność emocjonalna, problemy w relacjach od dłuższego czasu

SUBSTANCJE

— alkohol, marihuana, leki

04 💡 Mój plan diagnostyczny

CO OMÓWIĘ Z TERAPEUTĄ / PSYCHIATRĄ

— które zaburzenia warto sprawdzić, w jakiej kolejności

Klucz: Wéry & Billieux (2017) w przeglądzie systematycznym wykazali, że **diagnostyka PPU bez screeningu zaburzeń współwystępujących** jest jedną z głównych przyczyn niepowodzeń terapii. Pacjent uczy się technik kontroli impulsów, ale wciąż wraca do porno — bo jest narzędziem regulacji nieleczzonej depresji. Stąd zasada: **pierwsze 2-4 sesje to diagnostyka pełnego obrazu klinicznego**, nie wdrażanie technik. Może wymagać konsultacji psychiatrycznej. Czas zainwestowany w diagnostykę zwraca się wielokrotnie w skuteczności terapii.